

УДК:616.51/.53-006

Г.Б. Адильбаев, В.В. Шипилова, Г.Ж. Кыдырбаева, Д.Н.Ахметов, М.Е. Кайбаров, Г.Г.Ким
Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Непосредственные результаты функционально-щающего противоопухолевого лечения больных с опухолями головы и шеи

Аннотация. Цель - повышение эффективности комплексного лечения и улучшение качества жизни больных с местнораспространенным раком головы и шеи. В результате исследований разработан и апробирован комплексный метод лечения местно-распространенного рака опухолей головы и шеи включающий конкурентные курсы химиолучевой терапии с применением препарата группы таксанов и проведением параллельной лучевой терапии методом мультифракционирования доз. Разработанная методика позволила повысить общий положительный клинический эффект до 90,8% у больных раком гортани, до 92,2% - у пациентов со злокачественными опухолями слизистой оболочки полости рта и до 77,7% - у больных с раком верхней челюсти, без увеличения токсических проявлений противоопухолевой терапии. В результате чего были выполнены органосохраняющие операции, значительно улучшившие качество жизни данных пациентов.

Ключевые слова: опухоли головы и шеи, химиолучевая терапия, органосохраняющие операции.

Проблема лечения местнораспространенных злокачественных опухолей головы и шеи является одной из сложнейших в современной онкологии. В связи с этим ведутся поиски в направлении разработки и совершенствования органосохраняющего лечения [1, 2]. Использование химиотерапии и лучевой терапии, применяемых одновременно или последовательно, может быть одним из перспективных направлений в улучшении эффективности лечения больных злокачественными опухолями головы и шеи [3, 4].

Материалы и методы

В исследование вошли 33 пациента с морфологически верифицированным плоскоклеточным раком. Из них 10 больных местнораспространенным раком гортани, 13 пациентов - раком органов полости рта и 9 больных - раком верхней челюсти получивших комплексное лечение в «отделении опухолей головы и шеи».

Все больные получили конкурентные курсы химиолучевой терапии в два этапа с 2х недельным интервалом. Закрывающиеся в проведении МХТ препаратом паклитаксел, и параллельным курсом ДГТ методом мультифракционирования доз до СОД 40 Гр.

Третий этап проводился после оценки эффективности: при частичной регрессии опухоли больным проводилось радикальное функционально-щающее оперативное вмешательство. При полной регрессии опухоли – под-

держивающие курсы полихимиотерапии.

Результаты и обсуждения

После первого этапа лечения у всех пациентов отмечена частичная регрессия опухолевого процесса (более 50%), лечение без эффекта и прогрессирование опухоли в процессе лечения не отмечено ни у одного больного.

Таблица 1 - Непосредственные результаты лечения больных после второго этапа химиолучевой терапии

Группа	Кол-во больн.	Показатели степени регрессии			
		100 %	меньше или равно 50%	< 50%	Прогрессирован.
Гортань	(n=11)	3 (27,2%)	7 (63,6%)	1 (9,0%)	0 (0%)
Полость рта	(n=13)	4 (30,7%)	8 (61,5%)	1 (7,6%)	0 (0%)
Верхняя челюсть	(n=9)	1 (11,1%)	6 (66,6%)	1 (11,1%)	1 (11,2%)

Как видно из таблицы 1, полная регрессия опухоли после двух этапов химиолучевой терапии достигнута у 27,2% больных раком гортани, 30,4% - раком полости рта, 11,1% - раком верхней челюсти. При этом частичная регрессия опухоли достигнута у 63,6%, 61,5% и 66,6% больных, соответственно.

Прогрессирование опухоли зарегистрировано у одного (11,2%) больного раком верхней челюсти. Без эффекта лечение прошло в 9,0%, 7,6% и 11,1%, соответственно.

Таким образом, положительный клинический эффект отмечен у 90,8% больных раком гортани, 92,2% больных раком полости рта и 77,7% пациентов раком верхней челюсти.

Гематологических и нейротоксических осложнений, а так же явлений интоксикации в ходе химиолучевого лечения не зарегистрировано.

При проведении ДГТ наблюдались явления катарального радиоэпитеита у 63,6% больных раком гортани, 38,4 % раком полости рта, 66,6% раком верхней челюсти. Явления пленчатого радиоэпитеита отмечены у 36,3%, 46,1% и 33,3% больных, соответственно. У 15,3% пациентов раком полости рта отмечены явления разлитого пленчатого радиоэпитеита.

В качестве иллюстрации приводим выписку из и/б № 2909 больной И., 58лет. Которая находилась в отделении с диагнозом рак верхней челюсти слева с распространением



До лечения

После химиолучевой терапии
Рисунок 1 - КТ верхней челюсти

в полость носа слева, T3N1M0, ст. III. Больной согласно протоколу лечения с 11.04.12г. произведена два курса химиолучевой терапии препаратом паклитаксел и лучевая терапия СОД-60 Гр. После планового перерыва по данным КТ (рисунок 1) установлены частичный эффект и 26.06.12г. произведено функционально-щадящее оперативное лечение.

Далее больные, закончившие курс химиолучевой терапии с полной регрессией опухоли, находятся под наблюдением и получают противо- рецидивные курсы полихимиотерапии.

Четверым пациентам с диагнозом рак полости рта закончившим химиолучевое лечение с частичной регрессией опухоли произведены органосохраняющие операции в показанном объеме. Из них в 2 случаях в послеоперационном материале клеток опухоли не обнаружено - патоморфоз IV степени. Двоим больным произведена шейная лимфодиссекция при полной регрессии первичного очага.

Всем (6) больным раком верхней челюсти при частичной регрессии опухоли произведены органосохраняющие операции. Из них у 2 пациентов в послеоперационном материале установлен патоморфоз IV степени.

При раке гортани двоим пациентами произведена резекция гортани, остальные воздержались от хирургического лечения и получают курсы адывантной ПХТ.

Таким образом, разработанная нами методика органосохраняющей противоопухолевой терапии больным раком головы и шеи, позволяет повысить непосредственную эффективность лечения, не повышая при этом частоту и характер осложнений, тем самым улучшая качество жизни пациентов.

Список литературы

1. Решетов И.В. Чисов В.И. и др. Микрохирургическая реконструкция слизистой оболочки полости рта и глотки толстокишечно-сальниковым аутоотрансплантатом у онкологических больных //Мат.Всероссийской научно-практической конф. с междунар. участием «Опухоли головы и шеи». -М., 2006.- С. 100.
2. Bhawna Kumar, M.Sc., Kitrina G.Gordel et al. Expression of 53 and Bcl-xl as Predictive Markers for Larinx Preservation in Adwanced Laringeal Cancer//Arch Otolaryngol Head Ntck Surg. -2008. -Vol. 134, №4. -P.363-369.
3. Тамаркина Е.И., Миронова Е.Б., Жаркова О.В. и др. Химиолучевое

лечение местно-распространенного рака органов полости рта и ротоглотки // Вестник РОНЦ им.Н.Н.Блохина РАМН/-2006.-Т.17,№3.-С.49-52.

4. Kim N.W. et al . Specific association of human telomerase activity with immortal cells and cancer//Science.-2011.-Vol. 266.-P.211.

ТҮЖЫРЫМ

Г.Б.Адилбаев, В.В.Шипилова, Г.Ж.Кыдырбаева, Д.Н.Ахметов, М.Е.Кайбаров, Г.Г.Ким

Қазақтың онкология және радиология ғылыми-зерттеу институті
Бас және мойын ісігі бар науқастарға функциональді ісікке

қарсы емінің нәтижесі

Зерттеудің мақсаты: бас пен мойын қатерлі ісіктерімен ауырған науқастардың емінің нәтижелерін жетілдіру және науқастардың сапалы өмір сүруін жақсарту. Бұл зерттеуде жергілікті таралған бас және мойын қатерлі ісік ауруына шалдыққан науқастарға қатар химиосәулелі ем әдістемесі таксандармен және оған қоса мультифракциялы сәуле емімен қолданылды.

Қатар химиосәулелі ем әдістемесі жүргізу кезінде жалпы оң нәтиже 90% көмей қатерлі ісігінде, 90,8% - ауыз қуысы қатерлі ісігінде, 77,2% жоғарғы жақ сүйегі қатерлі ісігінде болды, Қолданылған ем тек емдеу нәтижесін тікелей арттыру мен қатар оның уытты әсерлерін нақты төмендетіп, ағза сақтау операцияларын жасауға және ең бастысы, аман қалу көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік берді.

Түйінді сөздер: бас және мойын рагы, сәулелі химио терапия, ағза сақтаушы операция

SUMMARY

G.B.Adilbaev, V.V.Shipilova, G.Z.Kydyrbaeva, D.N.Akhmetov, M.E.Kaibarov, G.G.Kim

Kazakh Research Institute of Oncology and Radiology
Immediate results of functional-sparing cancer treatment of patients with head and neck cancer

Purpose - improving the efficiency of complex treatment and improve the quality of life of patients with locally advanced head and neck cancer. The studies developed and tested a comprehensive treatment of locally advanced head and neck cancer; including competitive rates chemoradiation therapy with drugs of taxanes and parallel method multifraction radiotherapy doses. The developed technique has improved the overall clinical benefit to 90.8% in patients with cancer of the larynx, to 92.2% in patients with malignant tumors of the oral mucosa and to 77.7% - in patients with cancer of the upper jaw, with no increase toxic effects of anticancer therapy. As a result, operations were performed to save human body, greatly improving the quality of life of these patients.

Keywords: head and neck cancer; chemoradiotherapy, ablative surgery